

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

P. Suárez Santos, M. Castañón Apilanez, E. Suárez San Martín, C. García Fernández.

INTRODUCCIÓN

Definición

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica inflamatoria del sistema nervioso central, perteneciente al grupo de las enfermedades desmielinizantes, de etiología desconocida y base inmunológica. En ella, se produce un daño de la mielina del SNC, provocando áreas parcheadas de inflamación, gliosis y degeneración axonal.

Epidemiología

- Afecta predominantemente a adultos jóvenes. La edad de presentación más frecuente se sitúa entre los 20 y los 40 años. Es infrecuente su inicio por debajo de los 10 años y por encima de los 60.
- Más frecuente en mujeres (relación 4:1).
- Principal causa de discapacidad por enfermedad neurológica en pacientes jóvenes en los países desarrollados.

Formas clínicas

Atendiendo al curso evolutivo de la enfermedad, se han descrito clásicamente cuatro formas clínicas:

- EM remitente recurrente (EM-RR): es la forma más frecuente de inicio (86% de los casos). Curso en brotes desde el inicio de la enfermedad que se resuelven de forma parcial o completa y se intercalan con periodos de estabilidad clínica.
- EM secundaria progresiva (EM-SP): tras 15 años de enfermedad, hasta el 50% de los pacientes con diagnóstico de EM-RR evolucionan a una fase progresiva en la que pueden existir recaídas superpuestas.
- EM primaria progresiva (EM-PP): en un 5-10% de pacientes, la EM puede evolucionar de forma progresiva desde el inicio, sin producirse brotes definidos.
- EM progresiva remitente (EM-PR): se trata de una forma poco frecuente en la cual se producen exacerbaciones ocasionales en el contexto de un curso clínico progresivo desde el inicio.

DIAGNÓSTICO DE UN PRIMER EPISODIO

Habrà que sospecharlo principalmente en pacientes jóvenes (20-40 años), que presenten signos y síntomas neurológicos de reciente aparición, generalmente de instauración subaguda.

La clínica neurológica es secundaria a la lesión de la sustancia blanca del SNC, que puede producirse a cualquier nivel del mismo (encéfalo, médula, nervio óptico)

Los síntomas de inicio más frecuentes son los siguientes:

- **Afectación de vías largas motoras o sensitivas (46%):** Alteración de la fuerza o de la sensibilidad de distinta distribución dependiendo de la localización de la lesión (encéfalo, médula). Son más frecuentes los cuadros sensitivos que los motores. Importante buscar signos de afectación piramidal (signo de Babinski, clonus, hiperreflexia osteotendinosa...).
- **Neuritis óptica (21%):** Disminución de la agudeza visual de intensidad variable (visión borrosa, defectos en el campo visual, amaurosis) + Dolor retroocular con los movimientos +/-

Alteración en la visión de los colores (discromatopsia).

- **Fondo de ojo:** variable (normal en las neuritis ópticas retrobulbares, edema de papila en neuritis anteriores)
- **Afectación del tronco del encéfalo (10%):**
 - Oftalmoplejia internuclear: paresia del ojo aductor con nistagmus del ojo abductor en la mirada horizontal. Si la afectación es bilateral, sobre todo en pacientes jóvenes, es altamente sugestivo de EM.
 - Otros: Alteración de la motilidad ocular por afectación de los pares craneales óculo-motores, nistagmus patológicos, disartria, vértigo, afectación de otros pares craneales.
- **Clínica multifocal (23%), síndrome cerebeloso** (ataxia, dismetrías, inestabilidad, temblor intencional)

DIAGNÓSTICO DEL BROTE DE EM

Definición de BROTE: Exacerbación episódica de clínica neurológica preexistente o aparición de síntomas o signos nuevos, de al menos 24 horas de duración e instauración generalmente subaguda.

Diagnóstico diferencial:

- **PSEUDOBROTE:** Exacerbación de síntomas o signos neurológicos secundarios a una causa sistémica intercurrente
- **SÍNTOMAS PAROXÍSTICOS:** episodios estereotipados de segundos o minutos de duración. Los más típicos son la neuralgia del trigémino y el signo de Lhermitte. No constituyen en sí un brote a no ser que se repitan en múltiples ocasiones durante al menos 24 horas.

Situaciones que aumentan el riesgo de presentar un brote:

Inicio o suspensión de un tratamiento modificador de la enfermedad, fármacos anti-TNF (bloqueantes del factor de necrosis tumoral), tratamientos hormonales de fertilidad (Gn-RH), postparto, estrés.

Situaciones que provocan pseudobrotes:

En general pueden estar producidos por cualquier condición sistémica que presente el paciente. Algunas situaciones que se asocian con pseudobrotes son: fiebre e infecciones (principalmente infecciones urinarias y de tracto respiratorio superior), alteraciones metabólicas, exposición solar, calor intenso o baños en agua caliente, fármacos, ciclo menstrual, trastorno del sueño, ejercicio físico intenso.

Estudios complementarios urgentes:

Se solicitan con el objetivo de descartar pseudobrote. Según la sospecha clínica solicitar:

- Hemograma, bioquímica general, Sistemático y sedimento de orina y radiografía de tórax.
- En un paciente sin diagnóstico previo de esclerosis múltiple en el que se sospeche primer brote de la enfermedad se recomienda solicitar estudio de neuroimagen urgente.
- En un paciente con diagnóstico conocido de esclerosis múltiple y sospecha de brote de la enfermedad no es necesario realización de estudio de neuroimagen urgente salvo la existencia de síntomas atípicos que hagan sospechar otra etiología.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS**Tratamiento del brote:**

En general se recomienda el uso de altas dosis de metilprednisolona por vía intravenosa (1 gramo al día durante 3-5 días) seguida o no de prednisona oral en pauta descendente.

La misma dosis se puede utilizar por vía oral.

Si tras la retirada de los corticoides reaparecen los síntomas se puede repetir una nueva dosis de metilprednisolona.

Se debe remitir al paciente a consulta de neurología para conocimiento de su neurólogo responsable.

Tratamiento del pseudobrote:

Tratamiento de la condición asociada al mismo.

No está indicado el uso de corticoides.

TRATAMIENTO DEL BROTE
Recomendado:
Metilprednisolona 1 gr EV/VO x 3-5 días
Tratamiento posterior opcional con pauta descendente de corticoides:
Prednisona 60 mg VO diarios (disminución de 15 mg cada 5-7 días hasta suspender)

Efectos adversos más frecuentes de los tratamientos modificadores de la enfermedad que pudieran ser motivo de consulta urgente:**Inferferón Beta (Avonex, Rebif, Betaferón):**

- Reacciones cutáneas en el lugar de la inyección: irritación, dolor local, eritema, rash cutáneo, nódulos cutáneos, urticaria o lipoatrofia. En general no suelen ser graves, mejoran con una adecuada educación en la administración de la inyección. Si fuesen muy intensos, retirar el fármaco hasta valoración por su Neurólogo habitual.
- Síndrome pseudogripal tras la administración. Es frecuente sobre todo al inicio del tratamiento y va mejorando a lo largo de los meses. Se suele recomendar tomar paracetamol o ibuprofeno antes de la inyección y la administración del fármaco por la noche.
- Raras: depresión, alteración de pruebas de función hepática, alteraciones tiroideas o empeoramiento de la espasticidad. Si graves, retirar el fármaco y remitir a su Neurólogo habitual.

Acetato De Glatirámico (Copaxone):

- Alteraciones cutáneas en el punto de inyección. Mejoran con una adecuada educación en la administración de la inyección. Suelen ser transitorios.
- Aparición de una reacción sistémica que ocurre de manera impredecible en un 15% de los pacientes y que consiste en enrojecimiento, tirantez torácica, disnea y palpitaciones. Remite espontáneamente.

Natalizumab (Tysabri):

- Reacciones de hipersensibilidad. Son poco frecuentes, pero pueden ser muy graves. Deben tratarse como cualquier otra reacción de hipersensibilidad.
- La combinación de elevaciones de transaminasas y bilirrubina elevada, sin evidencia de

obstrucción es reconocido como un importante predictor de lesión grave del hígado que puede conducir a la muerte o la necesidad de un trasplante hepático en algunos pacientes. Tysabri debe interrumpirse en pacientes con ictericia o ante cualquier otra evidencia significativa de lesión hepática.

- Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). Se relaciona con seropositividad para vJC y con el tiempo de inmunosupresión previa. El mejor tratamiento de la LMP es el diagnóstico temprano. Por ello, se debe mantenerse alto nivel de sospecha ante cualquier paciente con EM tratada con natalizumab, que acuda a urgencias por cuadro de deterioro cognoscitivo, conductual, motor y de lenguaje de curso progresivo.
- Se recomienda ingreso para RM y eventual plasmaféresis o inmunoadsorción de confirmarse el diagnóstico.
- Síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica (tras la suspensión del fármaco). Se da en la gran mayoría de los casos de LMP y aparece entre unos días y varias semanas después de la plasmaféresis o de la inmunoadsorción. Consiste en la aparición de un deterioro neurológico junto con signos inflamatorios evidentes en la neuroimagen. Se recomienda ingreso para confirmación diagnóstica. Se sugiere que el uso de corticosteroides a altas dosis por vía intravenosa puede ser útil.

Fingolimod (Gilenya):

- Bradicardia y bloqueo AV de primer grado. Suele remitir espontáneamente
- Linfopenia, alteración de las transaminasas. En general suelen ser leves y no suelen precisar interrupción del tratamiento.
- Edema macular. Suele remitir tras suspender el fármaco.

Dimetilfumarato (Tecfidera):

- Rubefacción facial, síntomas gastrointestinales, aumento de transaminasas, proteinuria, linfopenia. En general suelen ser leves. Si graves, suspender el fármaco y remitir a su Neurólogo habitual.

Teriflunomida (Aubagio):

- Síntomas gastrointestinales, alteración de pruebas de función hepática, leucopenia, aumento de la tensión arterial, neuropatía periférica, estomatitis herpética. En general suelen ser leves. Si graves, suspender el fármaco y remitir a su Neurólogo habitual.

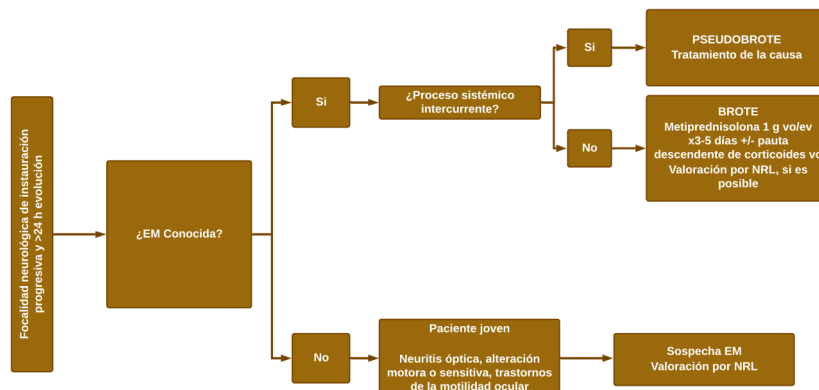
Alentuzumab (Lemtrada):

- Reacciones a la perfusión. Aparecen entre 30 minutos y 1 semana tras la administración. Se tratará con analgésicos, esteroides y antihistamínicos según tipo y gravedad.
- Enfermedad autoinmune: trastornos tiroideos, PTI y glomerulonefritis. Ante cualquier indicio de enfermedad autoinmune, deberá ponerse en conocimiento de los profesionales implicados para tratamiento precoz.
- Infecciones: las más frecuentes nasofaringitis, sinusitis, herpes oral, gripe, bronquitis e infecciones graves por VVZ. Se recomienda tratamiento de las mismas. Profilaxis con aciclovir 200mg/12h desde el primer día de cada curso de tratamiento y hasta al menos 1 mes tras el mismo, habrá sido indicada por su Neurólogo habitual.
- Los pacientes que siguen tratamiento con cualquiera de estos fármacos, normalmente deberían estar informados por su equipo de Neurología de la posibilidad de cualquiera de los efectos adversos mencionados. De la misma manera, deben seguir las revisiones clínicas, analíticas y de neuroimagen protocolizadas en cada caso.

- SOSPECHAR EM en paciente joven (20-40 años) con síntomas o signos neurológicos de

reciente aparición e instauración subaguda, especialmente si se trata de neuritis óptica, trastornos sensitivos o motores y alteraciones de la motórica ocular.

- En todo paciente con EM conocida que presente síntomas o signos neurológicos de reciente aparición o exacerbación de clínica preexistente, habrá que descartar procesos sistémicos intercurrentes para poder afirmar que se trata de un brote de EM.



BIBLIOGRAFÍA

- Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet 2008;372:1502.
- Miller D., Barkhof F., Montalban X., Thompson A., Filippi M. Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Lancet Neurol 2005;4: 281-288.
- Regina Radner Berkovich. Acute multiple sclerosis relapse. Continuum (Minneapolis) 2016;22(3):799-814.
- Olascoaga, J. (2014). Tratamiento de los brotes y recaídas. En E. Moral, M. Mendibe, C. Oreja, O. Fernández, X. Montalbán, A. Rodríguez (Eds). Guías diagnósticas y terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología 2014. Guía oficial de práctica clínica en esclerosis múltiple 2014 (75-76). Madrid (Quintana editores S. L.).
- Oliva Nacarino, P; Villafani Echazú, J. Apéndice. Controversias terapéuticas en esclerosis múltiple (55-61). Barcelona (EdikaMed, S.L.).